

17 - 09- Le Trouble Déficit de l'Attention/Hyperactivité (TDAH) - Pr. MANOUDI

(0:03 - 0:52)

Le deuxième cours, c'est le trouble déficit de l'attention, hyperactivité. Alors on va le définir, mais comme son nom l'indique, c'est un enfant qui va avoir aussi une triade qui est le déficit de l'attention, des troubles d'attention, troubles à suivre en classe par exemple, une hyperactivité, ne peut pas rester assis en classe, et une impulsivité. Donc on va voir les différentes rubriques pour le diagnostic, aussi il est important de poser le diagnostic de TDHA pour aussi aider l'enfant à avoir une scolarité normale.

(0:53 - 1:20)

De bons pronostics par rapport à l'autisme, mais aussi il a des retentissements par rapport au développement de la scolarité de l'enfant. C'est aussi un trouble neurodéveloppemental et il est défini aussi par l'association de trois types de symptômes, déficit de l'attention, hyperactivité et impulsivité. Le trouble est stable, permanent et envahissant le développement de l'enfant.

(1:22 - 3:09)

Là vous voyez aussi l'atteinte des différentes zones, des différents lobes du cerveau qui sont impliqués dans tout ce qui est mémoire, dans tout ce qui est attention, dans tout ce qui est motricité, donc le frontal, le parital, et selon la théorie neurobiologique, le TDHA est dû à un dysfonctionnement au niveau de certains neurotransmetteurs, notamment et surtout la dopamine, sinon la noradrénaline, au niveau bien sûr des zones, des lobes, des lobes cérébrales qui sont responsables de tout ce qui est contrôle de comportement et mémoire et attention. Affection aussi chronique qui est associée à des difficultés de fonctionnement psychosociales, durable et à une morbidité élevée, origine elle est multifactorielle, comme toutes les pathologies psychiatriques, il n'y a pas une cause, avec une prévalence plus élevée chez l'enfant, il y a des cas qu'on va détecter à l'âge adulte et il y a des associations aussi entre le trouble bipolaire et le TDHA chez l'adulte. La prise en charge, il est indiqué quand les symptômes constituent un handicap pour l'enfant, là il y a un médicament qui a beaucoup d'effets secondaires, donc la prise en charge médicamenteuse, on ne la fait que si elle est nécessaire, quand il y a vraiment un grand handicap, mais la prise en charge essentielle c'est la psychothérapie, la psychoéducation de l'enfant, de la famille, les parents et de l'école, des institutions.

(3:11 - 4:00)

Parce qu'ils doivent aussi connaître ce problème. La prévalence de 3 à 5%, il y a aussi une prédominance masculine, comme l'autisme, et la prévalence peut être sous-estimée chez les filles, parce qu'on tolère beaucoup plus les filles que les garçons, 50 à 60% conservent le trouble à l'âge adulte, donc ça peut persister jusqu'à l'âge adulte, mais il y a des chances que le trouble

se stabilise à l'âge adulte. Alors s'il y a aussi un facteur d'irritabilité, il y a un facteur génétique, si le parent en premier degré a le trouble, il y a un risque qui est multiplié par 5 pour que l'enfant ait aussi le même trouble.

(4:01 - 4:31)

Aussi, il y a une transmission chez les myonositotes plus que chez les disigotes, donc l'irritabilité est estimée à 80%. Il n'y a pas de gènes qui sont impliqués dans le TDAH, mais le gène le plus fortement associé est celui qui code pour le récepteur de palmes énergiques, on a dit qu'il y a un dysfonctionnement de palmes énergiques. L'importance, c'est l'interaction gène-environnement.

(4:31 - 5:01)

Comme ce que vous avez vu dans la schizophrénie, le gène est là, mais après c'est cette interaction entre le gène et l'environnement qui va déclencher l'apparition de la maladie. C'est la même chose pour le TDAH, le gène est là, mais il y a d'autres facteurs qui vont intervenir pour déclencher l'apparition de la maladie. C'est pour ça que toutes les maladies sont météorologiques, on ne dit pas qu'il y a une cause, mais il y a plusieurs facteurs qui inter-réagissent pour déclencher la maladie.

(5:02 - 6:23)

L'hypothèse, c'est un déficit en dopamine, c'est pour ça que dans le traitement on va donner des psychostimulants, il y a aussi un déficit en noradrénaline, il y a aussi une autre théorie qui parle d'une diminution du volume du cerveau et du cervelet chez les patients avec le TDAH. Les facteurs environnementaux aussi, comme dans les autres pathologies, il y a des facteurs de risque, notamment la consommation d'alcool ou bien être exposé à certaines substances pendant la grossesse, aussi la prématurité, la malnutrition, les troubles mentaux chez les parents, les violences, la maltraitance à un âge très précoce, l'exposition à la télévision de 1 à 3 ans, et ça c'est de plus en plus, faible niveau d'éducation des parents, faible niveau socio-économique. Alors l'enfant, ça apparaît chez l'enfant entre 6 et 12 ans, à l'autisme on a vu le début et les précoces, et entre 6 et 12 ans c'est l'âge de la scolarité et c'est là où des fois les instituteurs à l'école détectent le problème, s'ils sont sensibilisés sur le problème, sinon c'est un enfant turbulent.

(6:24 - 6:51)

On va appeler les parents pour un enfant turbulent qui n'écoute pas, qui est impoli, qui dérange les autres. Alors on remarque depuis longtemps, les parents vont remarquer l'excès d'activité, mais c'est lors de la scolarisation que les symptômes deviennent gênants, parce que l'enfant va gêner la classe. Alors les difficultés, elles sont précoces et comme on a dit, elles concernent l'attention, l'activité et l'impulsivité.

(6:51 - 7:18)

Voilà la triade, c'est une hyperactivité avec un trouble de l'attention et une impulsivité. Alors par rapport au trouble de l'inattention, on va décrire comment se présente l'enfant et vous allez imaginer, essayez d'imaginer un enfant comme ça pour garder en tête les symptômes. Donc par rapport au jeu, il passe peu de temps avec un jouet, il change très vite d'activité.

(7:19 - 8:02)

Il peut jouer aux voitures, rapidement il va aller jouer par exemple avec les consoles, rapidement il va aller jouer avec un autre jeu, donc il change rapidement les jeux. Par rapport au devoir, il est peu persévérant à l'effort et il se décourage vite, donc il n'a pas de patience, il n'arrive pas à maintenir un effort intellectuel soutenu, donc il doit faire beaucoup de pauses, on ne peut pas garder sa concentration plus longtemps. Il semble ne pas écouter ce qu'on lui dit, il va écouter pendant un laps de temps mais après il va être ailleurs, il ne va pas faire attention, donc il va sembler ne pas écouter et il est dans ses rêves.

(8:03 - 8:40)

Là vous voyez un petit peu comme l'autiste mais c'est différent, il est avec vous, c'est-à-dire il va vous suivre à un moment, mais à un moment il va lâcher et il peut revenir, ce n'est pas comme l'autiste, il est dans son monde tout le temps. L'autiste, vous le stimulez, il peut vous suivre mais en même temps il ne va pas être avec vous. Et s'il peut vous suivre, il va vous dire oui, oui, je vous ai écouté, oui, oui, j'étais là, oui, oui, qu'est-ce que vous voulez, oui, d'accord, vous voulez que je fasse mes devoirs, d'accord, je vais les faire, il y a quand même de la communication, mais la concentration, impossible de la garder soutenue plus longtemps.

(8:42 - 9:08)

Déjà un enfant normal, c'est 20 minutes maximum, vous-même c'est 20 minutes à une demi-heure. Depuis que je commençais à parler, vous avez lâché quand même un moment, vous êtes parti ailleurs. Alors que les gens qui sont sur Zoom, je crois qu'ils se sont même déplacés.

(9:09 - 9:43)

Donc là, lui, c'est difficile de soutenir son attention longtemps. À l'école, imaginez un enfant comme ça à l'école, il ne peut pas se concentrer. Et ça, les profs le constatent, il vous dit que je lui explique, tu as compris, qu'est-ce que tu as compris ? Là, il constate qu'il ne s'est pas concentré, qu'il n'était pas avec elle, il est aisément distrait, il est distrait, tout le temps dans la lune, il ne peut pas travailler seul, il doit toujours être avec quelqu'un qui va le stimuler pour avancer.

(9:44 - 10:34)

Tout seul, il va être distrait, demande plus de surveillance, assieds-toi correctement, écris la date, il va commencer à l'écrire, termine la date, souligne la date, commence à écrire la leçon, tout le temps doit être stimulé pour écrire à l'école ou bien pour faire ses devoirs. A l'air d'être dans le brouillard, comme s'il ne comprend pas, semble ailleurs, perd toutes ses affaires, bien sûr, c'est l'hyperactivité, il ne va pas pouvoir ramasser sa trousse, tout le temps il vient avec des éléments qui manquent au niveau de sa trousse ou bien au niveau de son cartable, il faut toujours tout lui répéter. Et ça, c'est parmi les consignes qu'on va donner au prof, lui donner des petites consignes et répéter, répéter à chaque fois.

(10:38 - 11:58)

Alors quand il est en groupe, il n'écoute pas les autres, il est là à travailler, à jouer, il joue bien sûr de façon fonctionnelle par rapport au jeu, au jouet qu'il utilise, mais il n'écoute pas les autres, lui il avance tout seul, a du mal à participer de façon adéquate à une conversation, parce qu'il est excité, il est impatient, donc il voudra parler plus que les autres, se concentre difficilement sur le prix et la coïncidence des autres, comme s'il est un petit peu égoïste, ça ne l'intéresse pas, intègre mal les règles du dialogue ou du jeu proposé. Donc s'il y a un jeu joué à tour de rôle, lui il ne va pas attendre son rôle, donc il est impatient d'attendre son rôle, il ne va pas respecter les jeux, et bien sûr quand on est en conversation avec lui, il ne respecte pas les règles de la communication, donc la communication, vous parlez, après quand moi je parle, vous m'écoutez. Donc lui, il est un petit peu dans la logorée, il voudra monopoliser la parole, s'adapte mieux en situation de duel qu'en groupe, quand il est en compétition avec quelqu'un, il s'adapte mieux et il peut fonctionner normalement qu'avec un groupe, avec le groupe il voudra faire ses règles à lui.

(12:01 - 23:31)

Alors par rapport au problème de l'impulsivité, il répond trop vite sans attendre la fin de la question, donc dès que la maîtresse pose la question, il peut répondre, avant même qu'elle finisse la question, il peut répondre, il casse les objets, les lunettes, ses jouets, sa bicyclette, sans penser aux conséquences, donc il est dans l'impulsivité, il bâcle pour finir le plus tôt possible tout ce qu'il fait, les devoirs, il va faire les devoirs rapidement juste pour en finir, il ne sait pas attendre, c'est l'impatience, l'impulsivité, il semble, quand on le voit comme ça, les instituteurs à l'école, c'est quelqu'un qui dérange, c'est quelqu'un qui ne laisse pas les affaires des autres, il va toucher les affaires des autres, il pourra casser les règles des autres par exemple, les trousse, il pourra les toucher, il ne va pas pouvoir soigner ses affaires, il répond à la place des autres quand la maîtresse pose la question, avant même que la maîtresse termine sa réponse, sa question, il répond, et ça bien sûr c'est vu en classe, il ne se tient pas en classe sur sa chaise, il va bouger, il peut même aller se lever et revenir, il est dans l'impossibilité de rester assis longtemps, ça pour les maîtresses, c'est un enfant qui est impoli, qui n'est pas bien éduqué, qui dérange, à la maison bien sûr, regardez comment il est, à la maison il présente la même chose, il paraît entraîné comme s'il est entraîné par un moteur, ou bien comme s'il est monté sur un ressort, il ne peut pas rester assis, il bouge tout le temps, il fait des bruits

incongrus, il n'arrête pas de parler, il est monté sur un ressort comme on dit, imaginez comme ça, il ne tient pas en place, il court, saute, bouge, il tripote tous les objets, touche par sa main tous les objets, donc à la maison ça dérange, cette hyperactivité, il peut y avoir la même en classe, la même en classe ce n'est pas accepté par la maîtresse, mais à la maison, surtout avec la maman, c'est beaucoup plus de perturbations, des fois ils ont peur ou bien ils sont dans une relation particulière avec les papas qu'avec les mamans, donc à l'école il ne reste pas assis sur sa chaise, donc il est dans l'impossibilité de rester assis, il se lève sans permission, il agite les jambes, les bras bien sûr, il se retourne pour parler aux élèves, il fait des bruits, il fait des commentaires à voix haute, si quelqu'un répond, il peut faire un commentaire, il peut répondre à la place des autres, renverse les affaires des autres ou bien ses affaires à lui, donc c'est un enfant turbulent, en hyperactivité, bien sûr à l'école il est en hyperactivité, à la maison il est en hyperactivité, à l'extérieur on ne peut pas sortir avec un enfant en hyperactivité, ça dérange beaucoup les enfants, les mamans et les autres, donc il ne reste pas à côté de ses parents et il risque bien sûr de se perdre, il risque de se faire mal, donc il vient et va dans les rayons par exemple, monter descendre les escaliers, les escalateurs, l'ascenseur, il risque de se faire mal, donc il se fait rejeter bien sûr, un enfant il est considéré par les autres comme un enfant turbulent, imaginez quand il sort par exemple pour jouer au parc avec les enfants, c'est un enfant qui ne va pas laisser les autres jouer tranquille, il ne va pas les laisser par exemple faire la queue pour descendre une balançoire par exemple ou bien pour jouer à la balançoire, c'est un enfant qui va être turbulent en hyperactivité, il désobéit, il a du mal à respecter les lois ou bien les consignes ou bien les règles, pour les autres il paraît comme un enfant impoli, mal éduqué, alors les autres particularités, c'est un enfant irrégulier et versatile, il change des fois, il est là avec vous en train de vous écouter, en train de jouer, mais par la suite il va commencer à s'agiter, à tourner, à aller à droite et à gauche à la maison et déranger les parents. Autoritaire et entêté, c'est pour ça qu'en groupe il ne va pas arriver parce qu'il voudra faire le chef, à la rigueur quand il est avec deux personnes, il peut, ce n'est pas accepter, mais il peut imposer son idée et être autoritaire avec un, mais avec un groupe c'est difficile, ils peuvent être aussi intelligents, il y a même parmi les TDAH des surdoués, il a une mémoire normale donc son estime de soi, il est menacé, pourquoi il est menacé, il est rejeté, il est traité d'impoli, il est traité de mal élevé, mal éduqué et aucun groupe ne voudra jouer avec lui, à l'école il est à chaque fois puni, chassé, mais devant le mur par exemple, il se met en danger quand il court, quand il saute, quand il est à l'extérieur, il peut se faire du mal, quand il joue à la bicyclette il peut se faire du mal, il est souvent mal accepté par les autres et ça, ça joue sur son estime de soi, donc les symptômes sont variables aussi, l'enfant pareil, comme je vous ai dit, plus obéissant et moins agité avec le père qu'avec la mère, il peut aussi être plus obéissant avec la maîtresse des fois, mais avec la maman, l'enfant se relâche, donc ce sont les mères qui sont les plus exposées à cette souffrance et puis c'est à la mère de contrôler l'enfant, même l'entourage, donc ça c'est vraiment une mère qui est très exposée, l'enfant il a moins de troubles dans les situations nouvelles, parce que ça reste quand même des enfants intelligents, dans les situations nouvelles ils veulent découvrir, donc ils peuvent prêter attention pour savoir par curiosité, savoir de quoi il s'agit, mais une fois la

situation n'est plus nouvelle, ils redeviennent alors anormaux, quand il est motivé aussi, il est aussi performant que les autres, quand il est motivé à apprendre un jeu par exemple, ou bien à connaître quelque chose, il est comme les autres, surtout dans les jeux, il est comme les autres, ses performances vont se dégrader quand il est fatigué, donc quand il est fatigué, il ne va plus avoir cette concentration et cette mémoire et cette attention. Le diagnostic et les cliniques, donc on ne peut pas ne pas poser le diagnostic devant un enfant pareil, les troubles de l'attention très sévères, les troubles hyperactivité et puis l'impulsivité, surtout cette hyperactivité elle attire l'attention, et dans deux milieux différents, il y a l'école qui vous dit qu'il est insupportable et impossible de sortir avec lui.

Donc ici aussi les mêmes critères, vous allez les trouver au niveau du DSM 5, les mêmes critères qu'on a vu. Alors pour évaluer, donc il y a des tests cognitifs pour évaluer le quotient intellectuel et il y a aussi des tests neuropsychologiques qui sont faits par des psychologues qui font des tests de neuropsychologie, pas tous les psychologues peuvent les faire, c'est des longs tests et vous aurez les réponses sur des pages et des pages, mais des tests qui vont détecter soit le fonctionnement exécutif, c'est-à-dire la programmation, l'action, le comportement de l'enfant, comment il va programmer une action par exemple, soit des tests qui vont détecter l'attention. Moi je vous ai mis quelques-uns juste pour avoir et que vous pouvez utiliser vous-même avec vos frères, vos petits frères, vos nièces, vos neveux, ça c'est le test de Stroop et même si je vous le fais moi, je pense que je vais avoir des troubles d'attention si je vous demande, mais rapidement, vous devez le faire rapidement.

Soit je vais vous demander de lire le mot, donc quand vous lisez le mot, vous devez faire abstraction à la couleur, soit je vais vous demander de me donner la couleur, vous devez faire abstraction au mot, d'accord, donc ça c'est pour détecter l'attention sélective, mais vous pouvez le faire rapidement, essayez de le faire, lisez le mot, là vous avez tous réussi, là ce que vous avez fait, vous avez fait l'attention sélective, vous vous êtes concentré sur le mot et vous avez fait abstraction à la couleur, donc lui ne peut pas faire ça, d'accord, ou bien si je vous demande la couleur, vous allez faire abstraction, vous allez vous concentrer sur la couleur, donc verte, verte, jaune, rouge, noir, vert, j'allais lire bleu, vous voyez, donc vous, ça vous paraît facile, essayez de faire ça avec les neveux, les petits-enfants, si vous avez des petits frères et sœurs et ça améliore l'attention sélective. Là aussi c'est un autre jeu où je vais vous demander de chercher la cloche, ça s'appelle le barrage de cloche, chercher la cloche, vous avez repéré, vous avez repéré quelques-uns, il y a une, il y a deux, il y a trois, il y a quatre, alors vous faites comme ça et bien sûr après on va compter le temps, si par exemple vous allez trouver toutes les cloches ou bien quelques-uns en un quart d'heure, la prochaine fois ça doit être en dix minutes, après en cinq minutes, c'est un entraînement. Ici ça s'appelle le trail marking test, alors c'est quoi l'objectif, vous avez deviné ? Liez les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ah j'ai réussi.

(23:33 - 25:23)

Ça c'est une autre façon, donc là 1A, 2B, 3C, vous voyez c'est comme ça et c'est le temps qui compte et même si vous le faites, si vous voulez un entraînement, si vous le faites comme je vous ai dit un quart d'heure, la prochaine fois il faut faire, là c'est pour la programmation, les fonctions exécutives, donc ça c'est de base par exemple, je vais vous demander par deux mouvements, ça vous le connaissez, c'est des jeux comme ça, par deux mouvements essayez de refaire le même schéma que le schéma de base ou bien par quatre mouvements refaites le même schéma ou bien par cinq mouvements refaites le même schéma, ça c'est un test qu'on fait aussi pour les patients en schizophrène. Alors ça c'est un test, ça aussi c'est intéressant, je vous ai mis en bas les explications, vous avez l'explication du test, comment on l'utilise, alors ça, vous voyez comment ils sont répartis, les cartes, ils sont différents en quoi? En couleur, en forme et en nombre. Alors comment ça se passe? Là, l'examineur va poser une carte, d'accord? Et l'enfant normalement, il doit comprendre, soit il doit les classer en nombre, en couleur ou en forme.

(25:23 - 27:56)

Donc quand l'examineur, par exemple, pose cette carte, l'examineur ne va pas dire à l'enfant, donnez-moi les cartes qui ont les mêmes couleurs, non, l'enfant va deviner lui-même la première fois comment il va faire au hasard. Par exemple, l'examineur a posé cette carte, qu'est-ce qu'il peut poser l'enfant comme carte? 1, 2, 4. Très bien, ça veut dire qu'il doit lui donner, soit en fonction des couleurs, lui donner ça, soit en fonction des formes, lui donner ça, soit en fonction du nombre, lui donner ça. Alors, quand l'enfant va poser 1, l'examineur, c'est lui qui a posé les règles dans sa tête, sans le dire à l'enfant.

Si l'examineur dit que c'est bon, l'enfant, qu'est-ce qu'il va comprendre? Qu'il faut les classer par couleur. Si l'examineur dit mauvais, qu'est-ce qu'il va comprendre? Par autre chose, soit par forme, soit par nombre. Après, il va poser, par exemple, celle-là.

Donc là, on va voir si l'enfant a compris la consigne. S'il lui dit bon, c'est bon, il va donner la deuxième carte rouge aussi. Ça veut dire que l'enfant a compris la consigne.

Si on lui dit c'est pas bon, c'est mauvais, il va poser une autre, ça veut dire qu'il a compris la consigne. Mais s'il continue la même chose, ça veut dire qu'il n'a pas compris la consigne. D'accord? S'il pose, par exemple, deux, et l'examineur lui dit c'est bon, il ne va donner que deux, les cartes avec deux figures.

Si l'examineur lui dit non, il va comprendre que l'examineur ne veut pas la couleur, ne veut pas le nombre, il veut la même forme. Il va commencer à donner la même forme. D'accord? Donc, voir si l'enfant, il a compris ou il n'a pas compris la consigne et il va continuer.

S'il a bien compris la consigne, par exemple, l'examineur veut la couleur, il va commencer à donner rouge, rouge, rouge, rouge, rouge. À un certain moment, l'examineur va changer la consigne dans sa tête. Quand l'enfant va poser rouge, parce qu'il a compris au début,

l'examineur va dire mauvais.

L'enfant va comprendre que l'examineur a changé de consigne. Il doit lui-même aussi changer de carte. Est-ce que vous avez compris? Et pour ça, il faut avoir une capacité, une attention pour pouvoir suivre.

(27:58 - 29:15)

Alors, dans les formes cliniques, il y a les formes qu'on trouve chez l'enfant d'âge préscolaire. On a beaucoup plus d'une hyperactivité, surtout quand il y a des stimulus extérieurs. Un enfant qui est stimulé par le bruit, est stimulé par les lumières.

Il y a aussi associé dans cette forme des troubles du sommeil, de l'alimentation et des diagnostics difficiles lorsqu'on n'a que l'hyperactivité. Surtout parce que l'enfant, un enfant normal, il doit bouger. Là, des fois, on pose le diagnostic de façon pas correcte, c'est-à-dire on va poser de façon en excès, alors que l'enfant ne présente pas de troubles d'hyperactivité.

L'enfant, il est juste un enfant qui veut jouer, qui aime bouger, qui a besoin d'activité sans qu'il soit ADHD. À l'adolescence, il y a une diminution de l'hyperactivité motrice avec l'apparition de conduite à risque et une diminution de l'estime de soi, vu tout ce qu'il a vécu pendant son enfance. Et si jamais il n'a pas passé une bonne scolarité, ça va se retentir à l'âge adulte.

(29:15 - 29:50)

Chez les filles, il y a beaucoup plus de formes impulsives et surtout plus attentionnelles que l'hyperactivité. D'ailleurs, déjà, les garçons sont problèmes et sont beaucoup plus actifs que les filles. Les comorbidités, on va trouver aussi d'autres troubles associés, notamment des troubles du langage, des échecs mathématiques, des troubles aussi au niveau de dyspraxie, au niveau des comportements par rapport à l'habillage, par exemple, la dysgraphie par rapport à l'écriture.

(29:50 - 32:39)

On va voir les troubles de langage la prochaine fois. Il peut y avoir associé des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des troubles oppositionnels avec provocation, parce que tellement ils sont difficiles à être contrôlés, les parents voudront faire plus de limites, plus de punitions. Les enfants vont être dans l'opposition dans la provocation des parents.

Des troubles de conduite, donc il y a beaucoup de troubles de comportement, des insomnies, des réveils nocturnes la nuit. Il peut y avoir aussi association avec le trouble du spectre autistique et avec d'autres troubles neurologiques, notamment le syndrome de Gilles de la Tourette. On résume toutes les comorbidités qu'on a vues avec le TDAH.

Il est beaucoup plus comorbide avec d'autres troubles. Les diagnostics différentiels, donc il y a les troubles qui sont causés par des problèmes organiques, donc avant tout pour parler de

TDAH, il faut éliminer tout ce qui est organique. Il y a les troubles oppositionnels avec provocation qu'on trouve surtout chez les adolescents.

C'est des adolescents opposants qui cherchent à provoquer l'adulte. Les autres troubles neurodéveloppementaux, les TSA, donc on vient de voir qu'il y a quand même une grande différence, surtout par rapport aux interactions sociales, comprendre les autres, comprendre l'émotion des autres, être présent. On le trouve chez le TDAH par rapport au TSA.

Le trouble de l'humeur dépressive, on va voir l'enfant dépressif, des fois il n'arrive pas à exprimer sa tristesse, il va l'exprimer par l'irritabilité, par l'agitation, par la colère, par l'hyperactivité pour attirer l'attention. Trouble bipolaire, parce qu'on a vu l'hyperactivité, le trouble de l'attention, c'est exactement ce qu'on avait vu dans l'état maniaque, dans l'accès maniaque. C'est des gens qui vont fonctionner à 100 à l'heure, donc ils font tout en excès.

Donc ça, ça peut prêter confusion avec le trouble bipolaire. Les troubles anxieux, donc notamment les troubles associés, mais les troubles anxieux que vous avez vus, il y a toujours des critères qui peuvent différencier avec les troubles TDAH. Les troubles de l'apprentissage, donc quand l'enfant a des dysgraphies ou bien a des problèmes d'apprentissage qu'on va voir la prochaine fois, ça peut prêter confusion avec surtout le cas de trouble de l'attention chez l'enfant avec TDAH.

(32:39 - 33:11)

Le trouble de la personnalité, mais en général, on ne parle pas de troubles de personnalité avant 15 ans. Donc là, c'est parce que c'est un enfant turbulent, instable, impulsive, et ça peut prêter confusion avec des troubles psychopathiques ou bien antisociaux. L'épilepsie, lorsqu'il y a la crise classique de l'épilepsie, on a de l'agressivité, de l'agitation, mais là aussi, il y a d'autres signes associés qui peuvent faire la différence.

(33:11 - 33:46)

Des fois, il peut y avoir des prises toxiques ou bien des prises médicamenteuses, comme ce qu'on a vu chez l'accès maniaque, la prise d'alcool, la prise de drogue, ça donne des excitations maniaques, des perturbations du comportement qui peuvent prêter confusion avec le TDAH. Les symptômes sont présents partout depuis toujours. Comme on a dit au début, c'est stable comme symptôme et c'est ça qui va pouvoir poser le diagnostic.

(33:46 - 35:02)

Si c'est un symptôme intermittent, bien sûr, c'est un problème, soit un problème relationnel avec les parents, soit que l'enfant veut attirer l'attention des parents, soit c'est un problème lié à l'environnement, un trouble d'adaptation à l'environnement. Parce qu'il y a des enfants turbulents, mais par moment, ils peuvent être turbulents en classe de temps en temps, ils peuvent être

turbulents, par exemple, à la maison de temps en temps, ou bien suite à des événements, par exemple, à la naissance d'un petit frère, l'enfant peut présenter des turbulences, des troubles de comportement, de l'agitation, de l'impulsivité pour attirer l'attention des parents. Mais quand c'est constant, présent partout, ça, on peut dire que ça peut être un TDAH.

Là, maintenant, vous allez voir les mamans, même des fois, les maîtresses, les instituteurs à l'école, ils parlent beaucoup de TDAH à chaque fois que l'enfant est turbulent, instable, même si c'est par moment. Donc, c'est un diagnostic qu'on pose aussi par excès, des fois. C'est devenu la mode.

TDAH, c'est devenu la mode. Dès qu'un enfant est un petit peu actif, on parle de... alors que l'enfant, normalement, il doit être actif. Un enfant, c'est l'activité, c'est le jeu.

(35:05 - 37:01)

Soit parce que, des fois, c'est les parents qui ne sont pas tolérants, qui ne supportent plus, ou bien c'est l'école, des fois, c'est les maîtresses qui ne supportent plus, qui cherchent à avoir des enfants statues, qui ne bougent pas. Ça n'existe pas, un enfant qui ne bouge pas. Alors, d'abord, pour poser le diagnostic, puisque c'est un diagnostic clinique, éliminer les autres diagnostics, bien sûr, par un examen spécifique, par l'avis des autres spécialités.

Donc, le passage chez le pédiatre est obligatoire. Il va faire le tour de toutes les pathologies, faire le bilan en rapport avec les autres pathologies. Parce qu'en général, ce n'est pas le psychiatre ou le pédopsychiatre qui demande le bilan.

L'enfant, il vient avec tout le bilan déjà fait. Alors, l'évolution, elle est généralement bonne si le trouble est repéré préconçument et si les parents, l'école, l'enfant sont éduqués. C'est éduquer dans le sens d'avoir une psychoéducation pour prendre en charge le problème.

Sinon, à l'âge adolescent ou bien adulte, il peut y avoir des troubles des conduites, surtout des conduites addictives, toxiques. Et si le problème n'est pas résolu pendant la scolarité, il peut y avoir des échecs scolaires. Alors, la psychoéducation, comme on a dit, c'est la psychoéducation des parents, de l'enfant et même de l'école, parce que l'enfant doit être intégré.

La psychothérapie, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, on va travailler sur l'estime de soi parce qu'un enfant qui se sent rejeté par les camarades, rejeté par l'école, il va être beaucoup plus impulsif. Ça ne va pas le calmer, au contraire, ça va augmenter son agressivité et son impulsivité.

(37:01 - 37:42)

Donc, il faut jouer sur son estime de soi, son affirmation de soi pour pouvoir régler ses problèmes. Alors, bien sûr, une aide aussi orthophonique et une aide psychomotricienne chez le psychomotricien pour gérer l'impulsivité et améliorer la concentration. Il y a aussi l'hygiène de vie

qu'il faut respecter, donc des choses qui ont été évoquées, qui ont montré leur intérêt dans la prise en charge, notamment d'éminuer l'apport du sucre, l'apport des colorants, des conservateurs, surtout éviter de manger à l'extérieur tout ce qui est préparé à l'extérieur.

(37:43 - 38:14)

Et bien sûr, une alimentation riche en oméga-3, en fer, améliorer le sommeil et avoir une activité physique. Ce sont des enfants qui ont besoin de bouger, donc il faut régler leur activité physique. Travailler après bouger, après travailler, régler, respecter des temps de travail minimes et couper ces temps avec des pauses où l'enfant peut décharger ou bien peut être actif.

(38:14 - 40:19)

Il y a des écoles, si vous avez vu comment ça se passe dans les autres pays, les écoles pour les enfants ADHD, c'est des écoles spéciales ou bien des classes spéciales où on peut, ou bien même avec les autres élèves, si ça ne dérange pas, on peut proposer des moyens qui vont aider l'élève à être actif en même temps et en même temps pouvoir suivre. Par exemple, j'ai vu dans une école, on leur a proposé de s'asseoir, avoir leur table comme une bicyclette, s'asseoir sur une bicyclette. Donc, ils sont là en classe en train de faire la bicyclette et en même temps, ça les aide à se concentrer.

Ils sont dans la possibilité de rester assis, se concentrer et suivre un cours. Les cours, c'est minimum une heure. Ils sont dans la possibilité de suivre même pas un quart d'heure.

Donc, cet exercice leur a permis de se concentrer et d'avoir une bonne attention tout en gardant une activité. Si ça dérange les autres, bien sûr, ils sont dans une salle tout seuls, mais si ça ne dérange pas les autres, moi je les ai vus dans une classe avec les autres enfants. Bien sûr, avant ça, il faut faire la psychééducation, expliquer aux autres enfants, expliquer à l'école.

De toute façon, les enfants, ils voient cet enfant comment il est et ils vont le rejeter. Autant leur expliquer pour qu'ils l'intègrent. Alors, il y a des médicaments qu'on peut proposer à partir de 6 ans, mais c'est des médicaments, c'est des psychostimulants.

C'est des amphétamines. Donc, c'est des psychostimulants qui ont aussi des effets secondaires qui peuvent être graves. Donc, au Maroc, c'est rare.

Ils ne sont pas disponibles au Maroc, de toute façon, et c'est rare qu'on n'ait pas la main facile pour les prescrire. Il vaut mieux les laisser pour les cas très handicapants. Donc, passez par la psychééducation, passez par la TCC, le traitement chez l'orthophoniste, le psychomotricien et laissez ça pour les cas qui sont handicapants.

(40:22 - 42:53)

Conseil pour les parents, être positif. C'est astreignant, c'est fatigant d'avoir un enfant qui n'arrête

pas de bouger. Déjà, un enfant sans problème TDHA, il n'arrête pas de bouger.

Et les mamans, s'ils ont deux, trois enfants, c'est difficile. Mais un enfant comme ça à la maison, c'est insupportable. Donc, les encourager, les accompagner pour qu'il reste positif.

Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire avec un enfant comme ça? Les critiques, les punitions, le frapper, être agressif avec lui, violent avec lui et même des fois le mépriser. Vous êtes nul, tu es nul. Ils vont le comparer avec les autres enfants.

Ça, ça n'aide pas l'enfant. Donc, être encourageant. Donc, si l'enfant fait un effort, s'il arrive à se concentrer pendant dix minutes, un quart d'heure, bravo.

Quand même, tu es arrivé à terminer ton devoir, à te concentrer pendant cinq minutes, bravo à chaque fois. Et diminuer les punitions. Au lieu des punitions, je ne sais pas, essayer de lui donner des moyens pour être, pour exercer son activité.

Contrôler ses émotions parce qu'on a vu, ils peuvent être impulsifs, ils peuvent être des fois irritables. Être rassurant, surtout s'ils sont rejetés par un groupe ou par les amis. Être cohérent entre les parents parce que ça, c'est un problème.

Déjà, un enfant normal, un petit peu turbulent, ça crée des conflits entre les parents. Le père qui charra quand la mère quattru rabbe aussi toujours la faute à la mère. Marbeti est devant l'enfant.

Donc ça, il ne faut pas l'utiliser. Il faut que les deux parents soient en accord dans l'éducation de tous les enfants, encore plus un enfant avec TDAH. Réduire les distracteurs, bien sûr, parce que ça va distraire beaucoup plus l'enfant.

Tout ce qui est stimulation, surtout les jeux électroniques, les téléphones, la télévision. Alors, c'est vrai que c'est un problème qui peut faire souffrir l'enfant et l'entourage. Ça reste de bons pronostics par rapport à la TSA.

Il faut aussi le détecter précocement, surtout parce que ça va retentir. Ça peut retentir s'il n'est pas traité sur la scolarité de l'enfant. Et si l'école n'est pas sensibilisée, l'enfant peut être vraiment exclu de l'école.

(42:53 - 43:26)

Ou bien écarté, ou bien des fois, il est puni. À chaque fois, on le met dehors, il ne va pas profiter. Et des fois, on n'appelle même pas les parents.

On va le mettre dehors à chaque fois et on n'appelle même pas les parents. Alors, c'est pour ça que les enseignants doivent identifier ce problème. Ils doivent l'identifier, doivent être sensibilisés aussi pour ne pas être dans l'excès.

Tout enfant un peu actif est considéré comme TDAH par l'école des fois. Et merci.